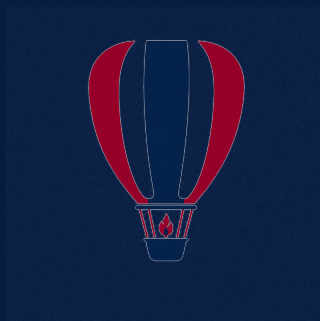


ШАРИК digital

Patient Flow Company для стоматологий



Delivery SOP

ШАРИК digital

Стандарты диагностики, производства и контроля качества

OS 2.0

7K пациентопотока

SOP для команды

00 / EXECUTIVE SUMMARY

Delivery SOP как производственная система

Этот документ фиксирует, как команда ШАРИК digital выполняет диагностику и внедрения по Patient Flow System. Он нужен, чтобы каждый специалист работал не по вкусу, не по привычке и не по хаотичному списку задач, а по единому стандарту: каждая работа должна закрывать конкретную потерю patient flow.

Главное правило производства

- Если задача не связана с одним из 7К пациентопотока, она вторична.
- Каждый вывод должен опираться на наблюдение, доказательство или данные.
- Каждая рекомендация должна вести к записи, лечению, возврату или контролю.

Что запрещено

- Делать аудит как список технических замечаний.
- Отдавать клиенту “много пунктов” без приоритета.
- Исправлять всё подряд без влияния на patient flow.
- Писать выводы без доказательств.

SOP	Зачем нужен	Главный результат
Карты	Проверить локальную точку выбора пациента.	Понятно, почему клиника проигрывает или выигрывает в картах.
Сайт	Проверить узел доверия, смысла и действия.	Понятно, что мешает пациенту записаться.
Отзывы	Проверить кредит доверия.	Понятно, как репутация влияет на выбор.
Мессенджеры	Проверить точку быстрого контакта.	Понятно, теряется ли пациент после сообщения.
Звонки	Проверить работу администратора.	Понятно, доводят ли обращения до записи.
CRM	Проверить контроль заявок и возврат.	Понятно, есть ли управляемая воронка.
Реклама	Проверить связку входа с записью.	Понятно, куда уходит бюджет после клика.
Конкуренты	Понять стандарт рынка.	Понятно, где клиника слабее и сильнее.
Карта потерь	Собрать выводы в управленческий продукт.	Понятен приоритет действий.
Контроль качества	Защитить стандарт результата.	Клиент получает не сырой аудит, а продукт.

01 / PRODUCTION LOGIC

Единый производственный цикл

Все направления диагностики проходят один и тот же цикл. Отличается объект проверки, но не логика производства. Сначала собираем данные, затем фиксируем факты, связываем их с 7К, оцениваем влияние и только после этого формулируем рекомендацию.

Этап	Действие	Выход
1. Входные данные	Получить доступы, ссылки, вводные, скриншоты, записи звонков, CRM-выгрузки.	Папка проекта и список проверяемых точек.
2. Проверка	Пройти путь пациента вручную и по чек-листу.	Набор наблюдений и доказательств.
3. Связка с 7К	Каждую проблему привязать к Касанию, Кредиту доверия, Конкретике, Контакту, Конверсии, Курации или Контролю.	Потеря имеет место в системе.
4. Оценка влияния	Оценить влияние на запись, лечение, возврат, выручку и управляемость.	Появляется критичность.
5. Приоритет	Разделить на быстрые исправления, критические потери и отдельные модули.	План действий.
6. Оформление	Собрать выводы в Карту потерь, отчет или задачу внедрения.	Готовый артефакт для клиента и команды.

Стандарт вывода

- Не писать: "сайт слабый". Писать: "на мобильной версии пациент не видит понятный следующий шаг, поэтому после интереса может не перейти к записи. Это потеря Конверсии".
- Не писать: "мало отзывов". Писать: "клиника проигрывает конкурентам в кредите доверия: рейтинг, свежесть и качество ответов ниже локального стандарта".

02 / MAPS SOP

Аудит карт

Проверить локальные точки выбора пациента: Яндекс Карты, 2ГИС, Google Maps и конкурентную выдачу.

Блок	Содержание
Цель	Проверить локальные точки выбора пациента: Яндекс Карты, 2ГИС, Google Maps и конкурентную выдачу.
Входные данные	Ссылки на карточки клиники; Основные услуги и направления; География и филиалы; 3-5 локальных конкурентов; Доступы к карточкам, если есть
Результат	Раздел Карты потерь по локальной видимости и доверию: что пациент видит в точке выбора, почему может уйти к конкуренту и что закрыть первым.

Последовательность действий

- Открыть карточки в Яндекс Картах, 2ГИС и Google Maps с мобильного и desktop.
- Проверить название, категории, адрес, телефон, режим работы, сайт, ссылки и мессенджеры.
- Проверить рейтинг, количество отзывов, свежесть, ответы клиники, негатив и фото.
- Сравнить карточку с ближайшими конкурентами по тем же параметрам.
- Зафиксировать 5-10 доказательств: скриншоты, ссылки, даты, примеры отзывов.
- Привязать каждую проблему к Касанию, Кредиту доверия, Контакту или Контролю.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Карточка находится по брендовому запросу	• Карточка находится по услугowym локальным запросам
• Категории соответствуют стоматологии и услугам	• Телефон и сайт актуальны
• Фото свежие и профессиональные	• Есть фото входа, кабинетов, врачей, ресепшена
• Отзывы свежие за последние 30-60 дней	• Негатив обработан спокойно и по делу
• Ответы не шаблонные	• Рейтинг не ниже локального стандарта
• У конкурентов нет явного преимущества по доверию	• Есть понятный маршрут к записи

Критерии качества

- Каждый вывод подтверждён скриншотом или ссылкой
- Есть сравнение минимум с 3 конкурентами
- Проблемы разделены на быстрые правки и системные задачи
- Нет общих фраз без влияния на patient flow

Ошибки, которые нельзя допускать

- Писать “нужно больше отзывов” без анализа качества
- Смотреть только Яндекс и игнорировать 2ГИС/Google Maps
- Не сравнивать с конкурентами
- Не фиксировать доказательства

03 / WEBSITE SOP

Аудит сайта

Проверить сайт как узел смысла, доверия и действия на пути пациента.

Блок	Содержание
Цель	Проверить сайт как узел смысла, доверия и действия на пути пациента.
Входные данные	Ссылка на сайт; Список ключевых услуг; Данные по трафику и заявкам, если есть; Мобильная версия; Конкуренты
Результат	Карта потерь сайта: где пациент теряет доверие, смысл или действие и какие изменения дадут наибольший эффект.

Последовательность действий

- Открыть сайт с мобильного и desktop.
- Пройти путь пациента от первого экрана до записи.
- Проверить первый экран, услуги, врачей, цены, доказательства, СТА, формы и контакты.
- Проверить скорость, читаемость, технические ошибки, мобильные барьеры.
- Зафиксировать точки, где пациент может не понять, не поверить или не совершить действие.
- Привязать проблемы к Конкретике, Кредиту доверия, Контакту и Конверсии.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Первый экран говорит, кто клиника и почему выбрать её	• Есть понятный следующий шаг
• СТА виден без прокрутки	• Услуги объяснены человеческим языком
• Есть врачи, фото, специализация и доказательства	• Цены объяснены или есть логика консультации
• Формы короткие и рабочие	• Телефон кликабельный на мобильном
• Мессенджеры видны	• Нет перегруза текста
• Сайт быстро открывается	• Страницы услуг ведут к записи

Критерии качества

- Проверены мобильная и desktop-версии
- Выводы связаны с пациентским поведением
- Есть приоритет: сначала действие и доверие, потом косметика
- Не предлагается редизайн без причины

Ошибки, которые нельзя допускать

- Оценивать сайт как дизайнер, а не как пациент
- Начинать с цвета и шрифтов
- Не проходить путь записи руками
- Писать “сделать современнее” без конкретики

04 / REVIEWS SOP

Аудит отзывов

Проверить, формирует ли репутационный контур доверие к клинике и врачам.

Блок	Содержание
Цель	Проверить, формирует ли репутационный контур доверие к клинике и врачам.
Входные данные	Карточки клиники; Отзывы на картах и площадках; Список врачей; Отзывы конкурентов; История ответов
Результат	Вывод о том, помогает ли репутация выбрать клинику или пациент уходит к конкурентам с более сильным кредитом доверия.

Последовательность действий

- Собрать количество отзывов, средний рейтинг и динамику по площадкам.
- Оценить качество отзывов: конкретика, врачи, услуги, эмоции, результат.
- Проверить ответы клиники на позитив и негатив.
- Сравнить с конкурентами в радиусе выбора пациента.
- Выделить репутационные риски и пробелы доверия.
- Привязать к Кредиту доверия, Конкретике и Контролю.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Есть свежие отзывы	• Отзывы не выглядят однотипными
• Есть упоминания врачей	• Есть отзывы по дорогим направлениям
• Негатив не оставлен без ответа	• Ответы клиники персональные
• Рейтинг конкурентоспособен	• Клиника не проигрывает по объёму отзывов
• Есть система сбора отзывов	• Есть контроль репутационных тем

Критерии качества

- Есть анализ не только количества, но и смысла отзывов
- Показаны 3-5 примеров сильных/слабых отзывов
- Сформулированы действия по сбору и ответам
- Оценены риски негатива

Ошибки, которые нельзя допускать

- Считать только рейтинг
- Не читать текст отзывов
- Не анализировать ответы клиники
- Не сравнивать с конкурентами

05 / MESSENGERS SOP

Аудит мессенджеров

Проверить, не теряется ли пациент после сообщения в WhatsApp, Telegram, VK или форме обратной связи.

Блок	Содержание
Цель	Проверить, не теряется ли пациент после сообщения в WhatsApp, Telegram, VK или форме обратной связи.
Входные данные	Ссылки на мессенджеры; Скрипты ответов; Время работы; История переписок, если доступна; Сценарий тайного пациента
Результат	Оценка потерь в Контакте, Конверсии, Курации и Контроле: насколько сообщение превращается в запись.

Последовательность действий

- Найти мессенджеры на сайте, картах и соцсетях.
- Проверить путь клика с мобильного.
- Отправить тестовое сообщение по согласованному сценарию.
- Зафиксировать скорость, тон, вопросы, доведение до записи.
- Проверить, фиксируется ли обращение в CRM.
- Оценить повторное касание, если пациент не ответил.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Мессенджер легко найти	• Клик работает с мобильного
• Ответ приходит быстро	• Администратор уточняет потребность
• Есть предложение записи	• Есть работа с сомнениями
• Нет сухого "что вас интересует?"	• Диалог фиксируется
• Есть повторное касание	• Есть контроль пропущенных сообщений

Критерии качества

- Есть тайминг ответа
- Есть скриншоты переписки
- Проверен не только факт ответа, но и качество доведения
- Вывод содержит конкретные скриптовые улучшения

Ошибки, которые нельзя допускать

- Считать, что наличие WhatsApp уже решает задачу
- Не проверять скорость ответа
- Не анализировать тон
- Не смотреть фиксацию в CRM

06 / CALLS SOP

Аудит звонков и администраторов

Проверить, как клиника обрабатывает самый дорогой момент patient flow - живой интерес пациента.

Блок	Содержание
Цель	Проверить, как клиника обрабатывает самый дорогой момент patient flow - живой интерес пациента.
Входные данные	Телефон клиники; Записи звонков; Скрипты; Регламент администраторов; Данные по пропущенным; Сценарий тайного пациента
Результат	Понятно, превращает ли администратор интерес в запись или клиника теряет горячий поток.

Последовательность действий

- Проверить видимость телефона на сайте и картах.
- Провести тайный звонок по согласованному сценарию.
- Прослушать 5-10 реальных звонков при наличии доступа.
- Оценить приветствие, выявление потребности, аргументацию, запись и работу с возражениями.
- Проверить возврат пропущенных и фиксацию в CRM.
- Связать выводы с Конверсией, Курацией и Контролем.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Телефон заметен и кликабелен	• Звонок принимают быстро
• Администратор представляется	• Уточняет проблему пациента
• Не отвечает только ценой	• Предлагает ближайшие окна
• Работает с "подумаю"	• Фиксирует контакт
• Возвращает пропущенные	• Есть контроль качества звонков

Критерии качества

- Есть конкретные цитаты или наблюдения
- Разделены ошибки скрипта и ошибки дисциплины
- Есть рекомендации для быстрого исправления
- Показано влияние на запись

Ошибки, которые нельзя допускать

- Оценивать администратора субъективно
- Не фиксировать факты
- Не проверять пропущенные
- Не связывать звонок с CRM

07 / CRM SOP

Аудит CRM

Проверить, есть ли у клиники контроль обращений, статусов, потерь и повторных касаний.

Блок	Содержание
Цель	Проверить, есть ли у клиники контроль обращений, статусов, потерь и повторных касаний.
Входные данные	Доступ в CRM; Воронка; Статусы; Источники; История заявок; Регламенты работы
Результат	Диагноз по управляемости patient flow после обращения: клиника контролирует поток или теряет его в CRM-хаосе.

Последовательность действий

- Проверить структуру воронки и статусов.
- Посмотреть, как фиксируются источники и обращения.
- Найти потерянные заявки, пропущенные статусы, зависшие сделки.
- Проверить задачи на повторные касания.
- Сопоставить CRM с звонками, мессенджерами и рекламой.
- Выделить проблемы Курации и Контроля.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Есть отдельные статусы по пути пациента	• Фиксируется источник
• Есть ответственный	• Есть дата следующего действия
• Нет сотен зависших заявок	• Есть причины отказа
• Есть работа с “подумаю”	• Есть повторные касания
• Есть отчёты по записи	• CRM используется ежедневно

Критерии качества

- Выводы опираются на реальные статусы и примеры
- Отдельно выделены проблемы настройки и дисциплины
- Показаны быстрые правки воронки
- Есть предложение по модулю CRM при необходимости

Ошибки, которые нельзя допускать

- Считать наличие CRM достаточным
- Не смотреть фактическое заполнение
- Не искать зависшие сделки
- Не связывать CRM с возвратом пациента

08 / ADS SOP

Аудит рекламы

Проверить не рекламный кабинет сам по себе, а связку “обещание - посадочная - действие - запись”.

Блок	Содержание
Цель	Проверить не рекламный кабинет сам по себе, а связку “обещание - посадочная - действие - запись”.
Входные данные	Рекламные кабинеты; Посадочные страницы; Офферы; UTM/аналитика; Заявки и записи; Бюджеты
Результат	Понятно, теряются ли деньги в рекламе или после рекламы: на сайте, обработке, CRM и повторных касаниях.

Последовательность действий

- Проверить, куда ведёт реклама.
- Сравнить рекламное обещание с посадочной страницей.
- Проверить наличие аналитики, целей и статусов.
- Оценить качество оффера и соответствие запросу пациента.
- Проверить, что происходит после заявки.
- Выделить потери Касания, Конкретики, Конверсии и Контроля.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Есть понятная цель кампании	• Оффер соответствует посадочной
• Посадочная ведёт к записи	• Цели настроены
• Заявки передаются в CRM	• Есть связь с записью, а не только лидами
• Понятна стоимость записи	• Нет трафика в слабую страницу
• Есть контроль качества лидов	• Реклама не усиливает протекающую систему

Критерии качества

- Не делается вывод “реклама плохая” без анализа после клика
- Есть проверка связки с посадочной
- Есть оценка аналитики
- Есть управленческий вывод по бюджету

Ошибки, которые нельзя допускать

- Смотреть только CTR/CPC
- Игнорировать обработку заявок
- Не проверять посадочную
- Обещать рост без диагностики системы

09 / COMPETITORS SOP

Аудит конкурентов

Понять локальный стандарт выбора пациента и показать, где клиника проигрывает или выигрывает.

Блок	Содержание
Цель	Понять локальный стандарт выбора пациента и показать, где клиника проигрывает или выигрывает.
Входные данные	3-7 конкурентов; Локация; Услуги; Карты; Сайты; Отзывы; Путь записи
Результат	Сравнительная карта локального patient flow: почему пациент может выбрать конкурента и какие зоны надо усиливать.

Последовательность действий

- Выбрать конкурентов по локации и ключевым услугам.
- Сравнить карты, рейтинг, отзывы и фото.
- Сравнить сайты, первый экран, услуги, врачей и СТА.
- Проверить путь записи у 2-3 конкурентов.
- Выделить сильные и слабые стороны клиники.
- Связать выводы с 7К и приоритетами.

Чек-лист диагностики

Проверка	Проверка
• Конкуренты выбраны не случайно	• Есть сравнение по картам
• Есть сравнение по отзывам	• Есть сравнение по сайту
• Есть сравнение по записи	• Выделены факторы выбора пациента
• Показано, где клиника проигрывает	• Показано, где можно быстро обойти конкурентов

Критерии качества

- Есть визуальные доказательства
- Конкуренты релевантны
- Выводы не превращены в копирование конкурентов
- Есть приоритеты по влиянию

Ошибки, которые нельзя допускать

- Сравнивать с нерелевантными клиниками
- Оценивать только дизайн
- Не смотреть путь записи
- Писать “конкуренты лучше” без объяснения почему

10 / LOSS MAP SOP

Подготовка Карты потерь

Карта потерь пациентов - главный диагностический продукт. Она не должна выглядеть как список проблем. Это управленческий документ, который показывает путь пациента, критические потери, доказательства, приоритеты и следующий шаг.

Этап	Что делать	Стандарт результата
Сбор данных	Собрать ссылки, доступы, CRM, звонки, карты, сайт, конкурентов, рекламные данные.	Есть полный список источников и пробелов.
Анализ 7K	Разнести наблюдения по Касанию, Кредиту доверия, Конкретике, Контакту, Конверсии, Курации, Контролю.	Каждая потеря привязана к блоку 7K.
Scoring	Оценить критичность, влияние, сложность и приоритет.	Появляется логика действий, а не хаос замечаний.
Выводы	Сформулировать управленческий смысл для собственника.	Понятно, как потеря влияет на запись/лечение/возврат.
Приоритеты	Выделить быстрые победы, критические потери, отдельные модули.	Понятен план на 7/30/90 дней.
Оформление	Собрать PDF/документ с доказательствами, таблицами и следующим шагом.	Клиент может принять решение о Fix/Growth.

Что нельзя отдавать бесплатно

- Полный список всех исправлений с пошаговой реализацией.
- Глубокий scoring по каждому блоку 7K.
- Подробный план внедрения по подрядчикам.
- Готовые скрипты, тексты, структуру CRM или ТЗ на сайт.
- Детальный 90-дневный roadmap без оплаты Карты или проекта.

11 / QUALITY CONTROL

Контроль качества

Контроль качества защищает агентство от главной ошибки: отдать клиенту красивый, но слабый документ без управленческой силы. Проверка проводится до отправки клиенту и до передачи в производство.

Что проверяем	Критерий допуска
Связь с 7К	Каждая проблема привязана к одному или нескольким блокам 7К.
Доказательность	Есть скриншоты, ссылки, цифры, цитаты или наблюдения.
Влияние	Понятно, как потеря влияет на запись, лечение, возврат или контроль.
Приоритет	Проблемы не равнозначны: выделены критические и вторичные.
Язык	Нет фраз "сделать красивее", "улучшить сайт", "вести SMM". Есть язык потерь.
Границы	Не отдан полный план внедрения бесплатно.
Оформление	Нет наложений, обрезаний, технического мусора и непонятных таблиц.

Кто проверяет

- Первичная проверка - координатор проекта или старший диагност.
- Финальная проверка - стратег/руководитель направления.
- Если документ идёт в продажу на высокий чек, проверяет собственник или коммерческий руководитель.
- Если есть сомнения по фактам, вывод не отправляется клиенту до проверки доказательства.

Абсолютные стоп-ошибки

- Нет связи с patient flow.
- Выводы без доказательств.
- Список задач без приоритетов.
- Обещание результата без оговорок и данных.
- Отсутствует следующий шаг.
- Клиенту отдали то, что должно продаваться как платная диагностика или модуль.

12 / FINAL STANDARD

Финальный стандарт Delivery SOP

Delivery SOP считается внедрённым, если команда способна стабильно производить диагностику и внедрения одинакового качества: без хаоса, без вкусовщины, без задач ради задач.

Минимальный стандарт результата

- Есть факт, доказательство и вывод.
- Есть связь с 7К.
- Есть влияние на patient flow.
- Есть приоритет.
- Есть следующий шаг.

Стандарт сильного результата

- Понятно, сколько хаоса снимается.
- Клиент видит стоимость бездействия.
- Команда понимает, что внедрять.
- Продажа следующего этапа становится логичной.
- Работа масштабируема и повторяема.

Роль	Что обязана делать по SOP
Диагност	Собирать факты, доказывать потери, связывать с 7К.
Координатор	Собирать данные, контролировать сроки и полноту проверки.
Специалист	Выполнять аудит своего направления по чек-листу.
Стратег	Формулировать управленческий вывод и приоритеты.
QA	Не выпускать слабые, субъективные или перегруженные документы.
Продажи	Использовать выводы не как аудит, а как мост к Карте, Fix или Growth.

Финальная формула

ШАРИК digital производит не набор digital-задач. Команда диагностирует, доказывает и устраняет потери patient flow. Если результат нельзя связать с маршрутом пациента, записью, лечением, возвратом или контролем - это не результат уровня Patient Flow Company.